内科学含诊断学 血液系统疾病

核心精讲·出血性疾病

（性感认识：ITP 产板型巨核细胞显著减少）血小板来自骨髓当中的巨核细胞

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、原发免疫性血小板减少症 ITP（特发性血小板减少性紫癜）

皮肤黏膜出血

（一）血小板过度破坏和血小板生成减少

（1）细胞免疫：CD8 T 细胞 不再爱过

（2）体液免疫 IgG 攻击Plt(打补丁)-ITP　IgG 攻击RBC(打补丁)-温抗体自免溶 ┐Evans综合征

①血小板相关抗体 PAIg（IgG）、血小板相关补体 PAC_3

②部分患者还可检测到抗心磷脂抗体、抗核抗体（类似 SLE）

VS 红斑狼疮也可以出现抗心磷脂抗体,血小板相关抗体和补体,也是育龄期女性多见

（二）临床表现

ITP → 月经过多 → 慢性失血 → 缺铁贫

缺铁贫可以跟ITP一起考
缺铁贫还可以跟PNH一起考

①育龄期女性多见，起病较隐匿

②血小板数量显著↓→反复皮肤黏膜出血（瘀点、紫癜、瘀斑、鼻出血、牙龈出血、月经过多等）缺铁贫　d<2mm、3-5mm、>5mm

③多无肝脾肿大。若反复发作可有轻度脾大 温抗体自免溶破坏RBC,所以有脾大功能旺盛,ITP破坏Plt(渣渣)不需要脾大

无肝脾肿大:不再iphone(再障、ITP、急性风湿热)

（三）检查

1.最重要——**骨髓穿刺**

①**巨核细胞数量正常或↑** 代偿作用(抗体也会破坏巨核细胞,所以不会数量明显增加)

②**巨核细胞发育成熟障碍**：体积变小、胞质颗粒↓、**幼稚巨核细胞**（颗粒型巨核细胞）↑、**产板型巨核细胞显著↓**

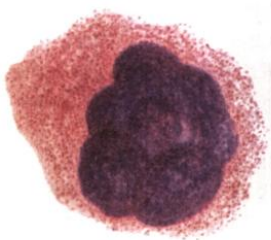
正常越长越大　发育成熟障碍

再障：骨髓巨核细胞数量显著减少（全片未见巨核细胞）

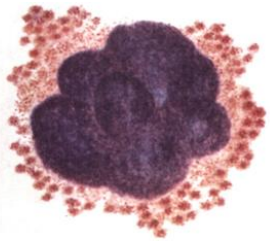
MDS：骨髓巨核细胞病态造血，呈小巨核细胞、核少分叶、多核

ITP:全片未见产板型巨核细胞,巨核细胞数量正常或↑

小巨核细胞可见于ITP(发育成熟障碍)和MDS(病态造血)



颗粒型巨核细胞(幼稚)



产血小板型巨核细胞(成熟)

血小板 ○○○○○　VS 肾衰竭毒素蓄积 Plt功能异常

2.**Plt 数量显著↓**、Plt 平均体积偏**大**，但 Plt **功能正常**。可有**正细胞或小细胞低色素贫血（合并缺铁贫）**。但 **WBC 多正常**。血细胞形态无异常　VS MDS:血细胞形态异常

一般:血液系统全血细胞↓
特殊:ITP无三系减少、自免溶无三系减少

反映血小板和CAP　ITP:Plt↓↓↓、Hb↓、WBC多正常

3.**出血时间 BT 延长**，束臂/毛细血管脆性试验 CRT 阳性，血凝块**收缩不良**，但**凝血功能**（TT、PT、CT、APTT）**正常** 凝血需要的Plt很少　血小板收缩蛋白

RBC↓、Plt↓、WBC正常时不能排除Evans综合征 温医的ooo宝宝红蜂病毒来吃药

4.伴自身免疫性溶血性贫血（**Evans 综合征**）者：**Coombs 试验阳性、血 UCB↑、Ret 明显↑**

=温抗体自免溶(攻击RBC)+ITP(攻击Plt)　溶血性黄疸

严重时可能影响骨髓当中的粒系,引起全血↓

（四）治疗

1.**急症**治疗 VS重型再障:15岁就网恋、无中意的、回来被打了20大板后成了智障

（1）用于：①**重症 ITP**（**Plt＜10** 伴活动性出血、出血评分≥5 分）、②**颅内出血（口腔血疱或视物模糊）**、③近期将实施手术或分娩者　十版新增